

Pasuruan, 13 Desember 2024

Nomor : 1838/RSPHS/E-BLS/DIR/XII/2024
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Surat Balasan Permohonan Perbandingan Hasil INM

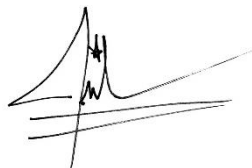
Kepada Yth.
dr. Imelda Fitria, S.H., MMRS
Direktur RSIA Husada Bunda
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti adanya surat dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda Nomor 75/E/XII/RSIA-HB/2024 tentang Permohonan Perbandingan Hasil Indikator Nasional Mutu RS, maka dengan ini kami lampirkan data capaian 13 Indikator Nasional Mutu RS Prima Husada Sukorejo.

Demikian surat balasan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Komite Mutu



Lidia Puspita Kencana, S.K.M.

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.

Lampiran

Surat Balasan Permohonan Perbandingan Hasil INM

Nomor :

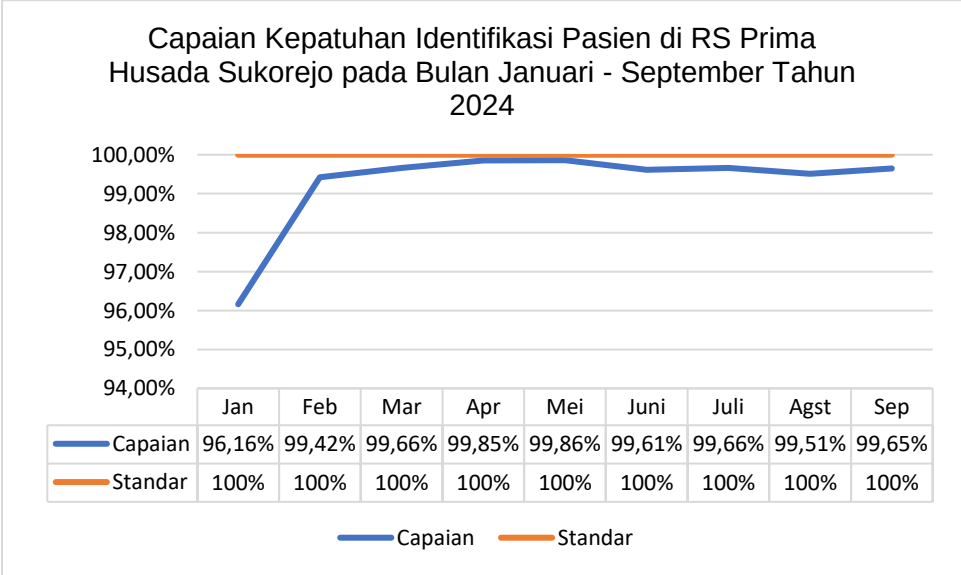
Capaian 13 Indikator Mutu Nasional Triwulan I - III di RS Prima Husada Sukorejo

No	Judul Indikator	Bulan									Std	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep			
1	Kepatuhan identifikasi pasien	96,16%	99,42%	99,66%	99,85%	99,86%	99,61%	99,66%	99,51%	99,65%	100%	99,26%	Tidak Tercapai
2	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency ≤ 30 menit	92,86%	100%	93,33%	100%	97,37%	90,91%	92,31%	92,86%	94,12%	≥80%	94,86%	Tercapai
3	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	61,60%	49,52%	53,64%	50,43%	63,46%	65,22%	59,68%	69,11%	73,20%	≥80%	60,65%	Tidak Tercapai
4	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	2,17%	0,97%	0%	0,68%	0%	1,27%	2,23%	2,34%	2,25%	≤5%	1,37%	Tercapai
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	73,96%	73,15%	79,48%	71,27%	71,09%	71,32%	70,25%	69,09%	68,23%	≥80%	71,98%	Tidak tercapai
6	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	Tercapai
7	Kepatuhan Penggunaan For-mularium Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥80%	100,00%	Tercapai
8	Kepatuhan Kebersihan Tangan	75,36%	73,57%	73,20%	73,23%	67,79%	78,3%	77,18%	71,97%	74,54%	≥85%	73,90%	Tidak tercapai
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	92,43%	94%	97,11%	97,76%	96,39%	97,26%	99,02%	97,15%	97,56%	100%	96,52%	Tidak tercapai
10	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	88%	90%	63%	72%	67,03%	90,45%	82,14%	84,85%	89,53%	≥80%	80,78%	Tercapai
11	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	82,26%	75,61%	61,11%	80,19%	80,61%	96,18%	97,30%	86,92%	89,15%	≥ 76.61%	83,26%	Tercapai

No	Judul Indikator	Bulan									Std	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep			
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥80%	100,00%	Tercapai
13	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	91,78%	95,56%	93,68%	96,37%	90,09%	90,88%	96,59%	93,86%	93,13%	100%	93,55%	Tidak tercapai

A. Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional Triwulan III di RS Prima Husada Sukorejo

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 1. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari - September Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada bulan Januari sampai bulan September Tahun 2024 mencapai 99.26%. Adapun hasil capaian pada Bulan September yakni 99,65%. Hasil Capaian pada Bulan September dibandingkan dengan rata-rata Bulan Januari sampai dengan Bulan September meningkat 0.39%.

Tabel 2. PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan September Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Bulan Januari - September Tahun 2024 adalah 99,26% dan belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Rencana : Meningkatkan capaian kepatuhan petugas terhadap identifikasi pasien Harapan : Petugas yang namanya masuk dalam kategori tidak patuh dapat dilakukan pemantauan kepatuhan saat identifikasi ke pasien. Tindakan : a. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien b. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh c. Koordinasi dengan kabid keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh d. Menghimbau dan mengingatkan ke semua staff di unit pelayanan mengenai pentingnya melakukan identifikasi pasien untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi kepada pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Cara mengidentifikasi petugas kepada pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) 2. Ketepatan waktu dilakukan identifikasi pasien (pemberian produk darah, obat, tindakan, pemeriksaan penunjang, diet)
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian Bulan Januari - September yakni 99,26% dapat disimpulkan bahwa kepatuhan identifikasi pasien belum mencapai standar 100%. Terdapat 4 unit yang belum patuh terhadap kepatuhan

	identifikasi pasien Instalasi Rawat Inap 2A (IRNA 2A), Instalasi Rawat Inap 2B (IRNA 2B), Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) dan di Maternitas
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari - September tahun 2024 mencapai 99,26%, masih ditemukan beberapa petugas di unit IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A & Maternitas yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien 2. Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 3. Memberikan catatan khusus tentang ketidakpatuhan staff dan diarsipkan dalam berkas SDM. 4. Karu mencatat juga dalam Form Evaluasi Kinerja yang terbaru terkait nama-nama staf yang tidak patuh dan direkap semesteran dan form tersebut harus di tandatangani oleh staf yang bersangkutan 5. Rapat Mutu dengan karu 6. Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu 7. Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik 8. Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin.

Tabel 3. Rencana Tindak Lanjut

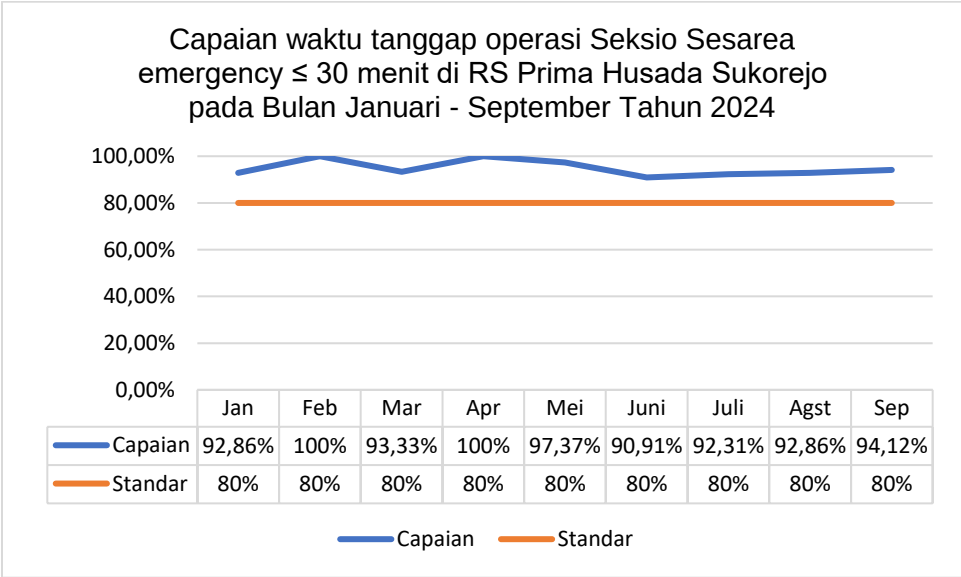
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah peneguran	Kepala Ruangan	Satu bulan
2	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah peneguran	Ka. Ruangan, Tim SKP, Kabid Keperawatan, SDM dan Mutu	Satu bulan
3	Memberikan catatan khusus tentang ketidakpatuhan staff dan diarsipkan	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan	Catatan Khusus staff yang tidak patuh	SDM	Satu bulan



No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	dalam berkas SDM.	pasien dengan benar	identifikasi pasien			
4	Karu mencatat juga dalam Form Evaluasi Kinerja yang terbaru terkait nama-nama staf yang tidak patuh dan direkap semesteran dan form tersebut harus di tandatangani staf yang bersangkutan	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Pencatatan staff yang tidak patuh dalam form evaluasi kinerja yang terbaru	Kepala Ruangan Unit Masing-Masing	Satu bulan
5	Rapat Mutu dengan Kepala Ruangan	Melakukan evaluasi terhadap kinerja system manajemen mutu	Kepala ruangan	Rapat Komite Mutu & Kepala Ruangan	Rapat Komite Mutu & Kepala Ruangan	Satu bulan 1 kali
6	Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu	Mutu Unit dapat terkontrol secara berkelanjutan dan masalah terkait mutu dapat segera di tindaklanjuti	Seluruh staff di Unit	Rapat Bulanan Unit	Rapat Bulanan di setiap Unit	Satu bulan
7	Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik	Staff yang bertugas paham terkait pembelajaran yang disampaikan	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala ruang kepada timnya terkait pembelajaran	Kepala Ruangan	Satu bulan
8	Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh	Kepala Ruang dapat mengetahui setiap petugas unit yang patuh	Seluruh staff di Unit	Supervisi yang dilakukan oleh kepala ruang dan mencatat	Kepala Ruangan	Satu bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	kepala ruang secara rutin.	terhadap identifikasi pasien		staff yang tidak patuh dalam form evaluasi kinerja yang terbaru		

2. Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency ≤ 30 menit

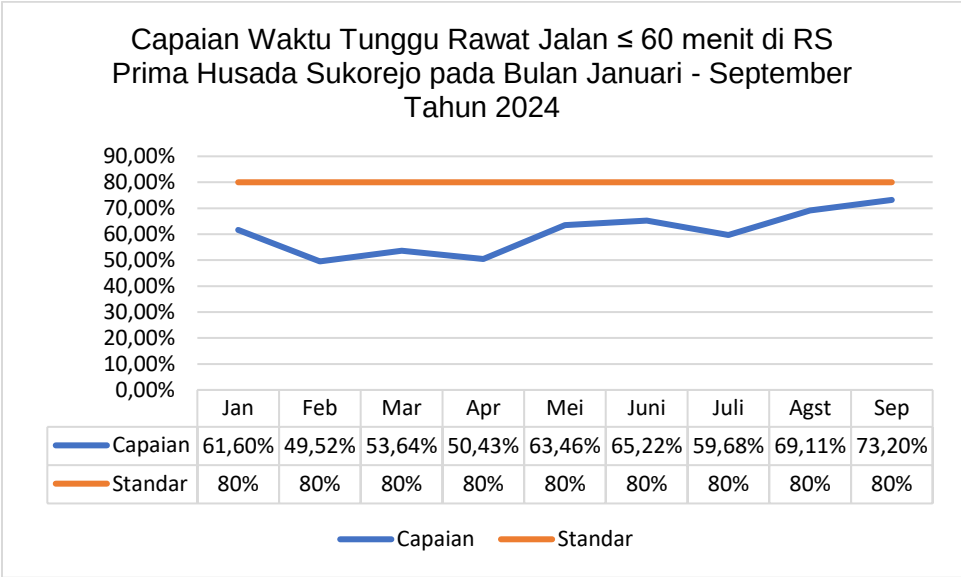


Gambar 3. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari – September Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan Januari sampai bulan September 2024 telah mencapai standar yakni dengan rata-rata 94,86%. Adapun hasil capaian di Bulan September Tahun 2024 yakni 94,12%. Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dan tindakan kurang dari 30 menit, sehingga operasi dilakukan secara tepat.

3. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit



Gambar 4. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari - September Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian di atas, waktu tunggu rawat jalan pada bulan Juli sampai Bulan September 2024 rata-rata capaiannya yaitu 60,65% sedangkan hasil capaian di Bulan September yakni 73,20%.

Tabel 4. PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit pada Bulan Januari - September Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit pada Bulan Januari - September Tahun 2024 adalah 60,65%, belum mencapai target 80%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan pasien
Plan	Rencana : Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien Harapan : Semua pasien mendapatkan pelayanan dokter kurang dari 60 menit Tindakan : a. Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Waktu pasien rawat jalan yang didaftarkan di tempat pendaftaran sampai dilakukan pemeriksaan oleh dokter
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian bulan Januari sampai bulan September yakni 60,65%. Disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan pasien yang kurang dari 60 menit belum mencapai target ≥ 80%. Ini dikarenakan: a. Adanya pasien yang meninggalkan ruang tunggu pelayanan poli sehingga ketika dilakukan pemanggilan pasien tidak langsung menemui dokter b. Adanya pasien yang daftar di ruang pendaftaran 1 jam sebelum jadwal poli c. Adanya dokter poli yang terlambat melebihi 30 menit
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian bulan Januari sampai bulan September yakni 60,65%. Disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan pasien yang kurang dari 60 menit belum mencapai target ≥ 80%. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Mengingatkan petugas Pendaftaran untuk mengKIE pasien Rawat Jalan

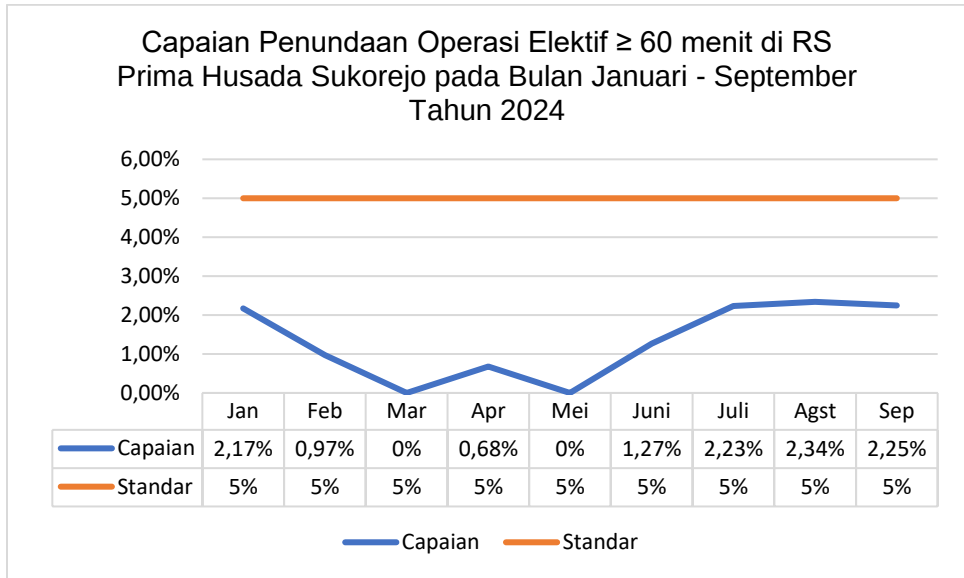


	2. Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien
	3. Monev khusus progress tiap minggu

Tabel 5. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi Petugas Pendaftaran untuk mengKIE Pasien Rawat Jalan	Semua Pasien mendapatkan KIE terkait ketentuan pelayanan di RS Prima Husada Sukorejo	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Rapat koordinasi dengan kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Kepala Ruang Pendaftaran, Komite PMKP, Kepala Bidang Pelayanan,	Satu bulan
2	Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Rapat koordinasi dengan kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Komite PMKP, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Satu bulan
3	Monitoring dan evaluasi terkait waktu tunggu rawat jalan pasien	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Supervisi yang dilakukan oleh Komite Mutu	Komite Mutu	Satu bulan

4. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit

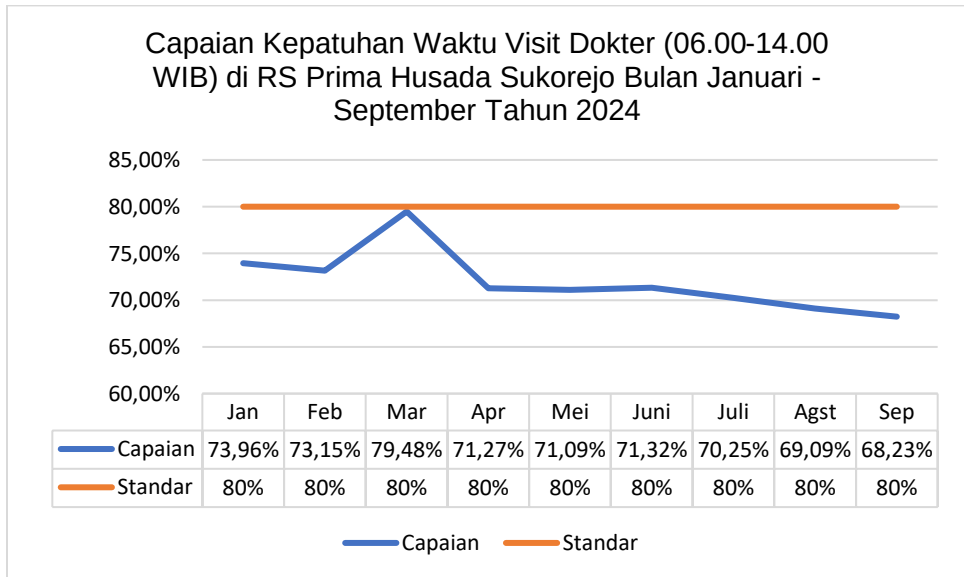


Gambar 5. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari – September Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan Januari sampai bulan September yakni 1,37% sedangkan capaian di Bulan September 2024 yakni mencapai 2,25% mencapai standar kurang dari 5%.

5. Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)



Gambar 6. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari – September Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap pada Bulan Januari sampai Bulan September 2024 mencapai 71,98%, sedangkan capaian pada Bulan September 68,23% Capaian tersebut belum mencapai standar ≥ 80%.

Tabel 6. PDSA Capaian Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB) pada Bulan September Tahun 2024

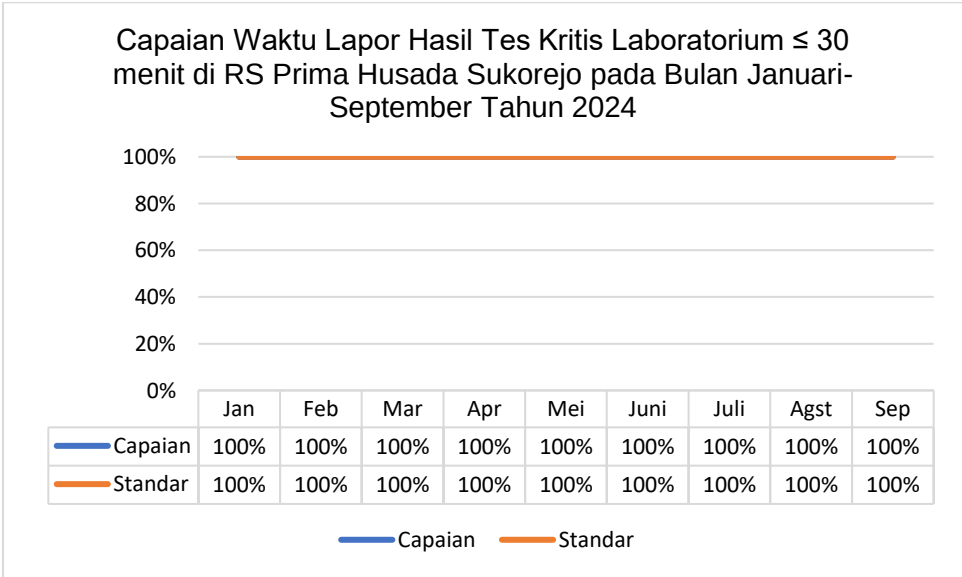
Problem	Rata-rata capaian waktu visite dokter pada Bulan Januari - September Tahun 2024 adalah 71,98%, belum mencapai target ≥80%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu visite dokter
Plan	Rencana : Meningkatkan capaian waktu visite dokter kepada pasien rawat inap Harapan : Semua pasien rawat inap dapat tervisite oleh dokter Tindakan : - Koordinasi dengan kabid pelayanan dan komite medik - Pemaparan jumlah dokter yang visite lebih dari jam 14.00 WIB dan dokter yang titip visit
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Kesesuaian waktu visite dokter kepada pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian Bulan Januari - September yakni 71,98% dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai ≥ 80%. Ini dikarenakan: - Rata-rata dokter visite yang lebih dari 14.00 WIB memiliki jadwal praktek di Rumah Sakit lain sehingga jadwal di RS Prima Husada Sukorejo lebih dari jam 14.00 WIB - Pasien masuk ke ruang ICU pada malam hari, sehingga visit dilakukan oleh dokter jaga dan di visit oleh DPJP di kemudian hari.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian Bulan Januari - September yakni 71,98% dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai ≥ 80%. Follow-Up dan Rencana Lanjutan - Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan dan komite medik terkait kepatuhan waktu visit dokter konfirmasi ke dokter jaga. - Mengatur waktu DPJP antara jam Poly, Jam Visite IRNA, jam Operasi adakah yg beririsan termasuk dengan jam praktek DPJP di RS lain - Koordinasi dengan asisten dokter terkait pasien yang harus di visit oleh DPJP - Koordinasi dengan pihak SDM terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien - Merekrut Home doctor

Tabel 7. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan dan komite medik untuk mengingatkan visit ke pasien	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang tidak visit ke pasien	Rapat koordinasi dengan komite medik	komite medik	Satu bulan
2	Mengatur waktu DPJP antara jam Poly, Jam Visite Irna, jam Operasi adakah yang beririsan termasuk dengan	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang tidak visit ke pasien	Rapat koordinasi dengan Dokter, Sekretaris Komite	Sekretaris Komite Medik, Kabid Pelayanan	Satu bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	jam praktek DPJP di RS lain.			Medik, Kabid Pelayanan		
3	Koordinasi dengan asisten dokter terkait pasien yang harus di visit oleh DPJP	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang tidak visit ke pasien	Rapat koordinasi dengan komite medik	komite medik	Satu bulan
4	Koordinasi dengan pihak SDM terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang tidak visit ke pasien	Rapat koordinasi dengan SDM	SDM	Satu bulan
5	Merekrut Home Dokter	Semua pasien rawat inap dapat tervisite	Home Dokter	Koordinasi dengan SDM terkait dokter yang tidak bisa visit	SDM	Satu bulan

6. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit



Gambar 7. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari – September Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada bulan Januari sampai bulan September 2024 yakni 100% sesuai standar. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

7. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

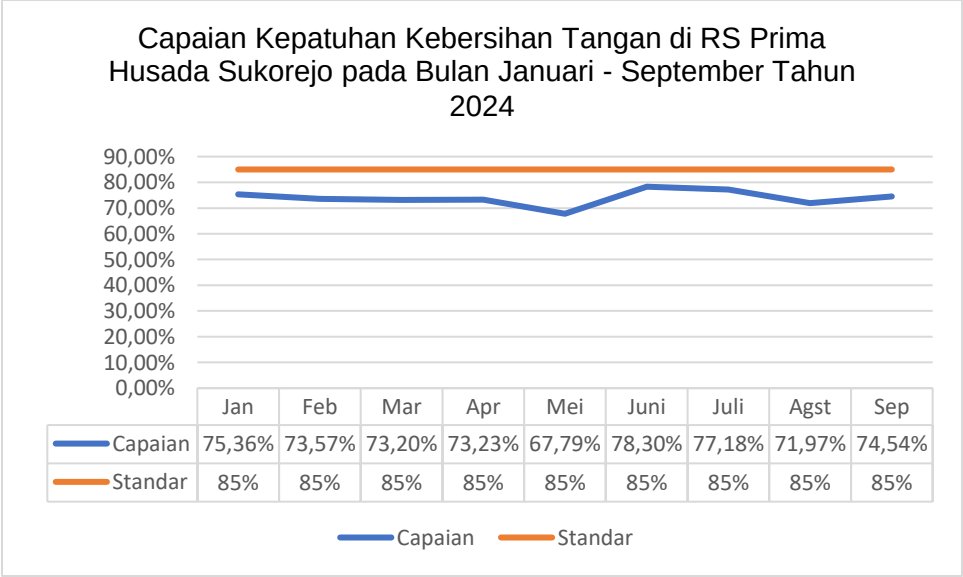


Gambar 8. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari - September Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mulai Bulan Januari sampai Bulan September Tahun 2024 telah mencapai standar yakni 100%. Unit Farmasi melakukan peresepan obat hanya dari Formularium Nasional.

8. Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 9. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari - September Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Bulan Januari September belum mencapai ≥85%, yaitu 73,90%.

Tabel 8. PDSA Capaian Kepatuhan Kebersihan tangan petugas pada Bulan Januari - September Tahun 2024

Problem	Persentase kepatuhan kebersihan tangan pada Bulan September Tahun 2024 kurang dari 85% yakni 73,90%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	- Rencana: Mengetahui kepatuhan kebersihan tangan secara berkesinambungan - Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. - Tindakan - Melakukan audit kebersihan tangan pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. - Kolaborasi dengan kepala ruang terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan - Membuat rencana metode role play kebersihan tangan untuk staff dengan masa kerja lebih dari 1 tahun
Do	Kepatuhan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen yaitu: - Sebelum kontak dengan pasien - Sebelum tindakan aseptik - Setelah terkena cairan tubuh pasien - Setelah kontak dengan pasien - Setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien
Study	Berdasarkan hasil capaian Kepatuhan kebersihan tangan di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Januari - September 2024 yakni 73,90% dan belum mencapai standar yang ditetapkan. Ini dikarenakan: - Handwash dan tissue paper towel dijumpai dalam keadaan kosong - Terdapat petugas yang tidak paham gerakan 6 langkah cuci tangan dengan baik dan benar - faktor dari perilaku kebiasaan petugas yakni kurangnya kesadaran/kepatuhan petugas dalam melaksanakan HH - Kurangnya pengetahuan petugas terhadap pentingnya kepatuhan HH untuk memutuskan mata rantai penularan kuman
Action	- Melakukan koordinasi dengan bidang penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dan ketersediaan fasilitas kebersihan tangan - Mengupayakan ketersediaan sarana kebersihan tangan seperti handrub ditiap bed tempat tidur pasien, air lancar, tersedianya tissue paper towel dan sabun. - Membuat jadwal edukasi rutin setiap bulannya ke ruangan - Meningkatkan kembali jumlah kunjungan dari IPCN ke ruangan. - Melibatkan kepala ruangan untuk sering memonev kepatuhan HH terhadap petugas - Berkoordinasi dengan SDM terkait kepatuhan kebersihan tangan staff saat audit yang termasuk dalam evaluasi kinerja - Melibatkan manajemen untuk memberikan perhatian dalam bentuk punishment dan reward terhadap petugas yang patuh dan tidak terhadap kepatuhan hand hygiene.



Tabel 9. Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Melakukan koordinasi dengan bidang penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dan ketersediaan fasilitas kebersihan tangan	Menjalin koordinasi secara berkesinambungan	Semua petugas terutama petugas medis	Rapat rutin antara Komite PPI, Kabid Umum	Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM	Satu bulan
2	Mengupayakan ketersediaan sarana kebersihan tangan seperti handrub di tiap bed tempat tidur pasien, air lancar, tersedianya tissue paper towel dan sabun.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	Setiap tempat memiliki air yang lancar, handrub, tissue paper towel dan sabun	Koordinasi dengan Kabid Umum, Komite PPI, Gudang Umum, dan CS	Komite PPI, Kabid Umum, Gudang Umum & CS	Satu bulan
3	Membuat jadwal edukasi rutin setiap bulannya ke ruangan	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan oleh petugas di ruangan	Semua petugas terutama petugas medis	Monitoring dan evaluasi berkala	Komite PPI	Satu bulan
4	Meningkatkan kembali jumlah kunjungan dari IPCN ke ruangan.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah termonitoring semua di setiap ruangan	IPCN dapat memonitoring di setiap ruangan	Monitoring dan evaluasi berkala	IPCN & Komite PPI	Satu bulan
5	Melibatkan kepala ruangan untuk sering memonev kepatuhan HH terhadap petugas	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan oleh petugas di ruangan	Kepala Ruang dapat memonev petugas di setiap unit terkait kepatuhan kebersihan tangan	Monitoring dan evaluasi berkala	Kepala Ruang, IPCN & Komite PPI	Satu bulan

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
6	Melakukan koordinasi dengan SDM terkait kepatuhan kebersihan tangan staff saat audit yang termasuk dalam evaluasi kinerja	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan mendapat perhatian khusus dari petugas	Semua petugas terutama petugas medis mendapatkan perhatian dari manajemen RS	Monitoring dan evaluasi berkala	SDM, IPCN & Komite PPI	Satu bulan
7	Melibatkan manajemen untuk memberikan perhatian dalam bentuk punishment dan reward terhadap petugas yang patuh dan tidak terhadap kepatuhan hand hygiene.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan mendapat perhatian khusus dari petugas	Semua petugas terutama petugas medis mendapatkan perhatian dari manajemen RS	Pemberian Reward dan punishment terhadap kepatuhan <i>hand hygiene</i>	SDM, Kabid Kepelayana n, Kabid Keperawatan, Kabid Penunjang & Kabid Umum	Satu bulan

9. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 10. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari - September Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2024 adalah 96,52%. Adapun capaian di Bulan September tahun 2024 yakni 97,56% yang angka tersebut belum mencapai target 100%.

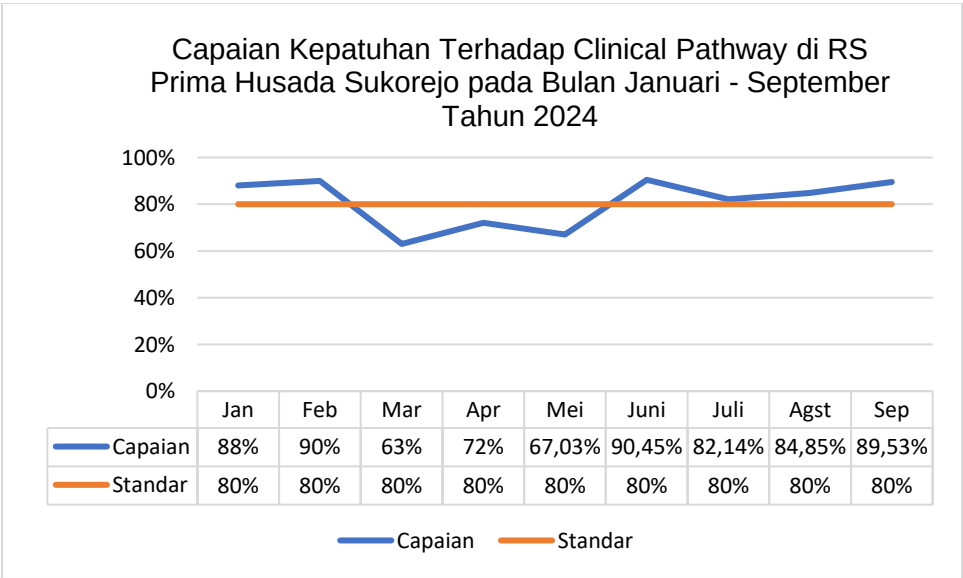
Tabel 10. PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Bulan September Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Bulan Januari - September Tahun 2024 adalah 96,52%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Rencana : Meningkatkan pengetahuan petugas mengenai pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh Harapan : Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien cedera akibat pasien jatuh dapat tercapai 100% Tindakan : koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal pasien - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap - Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Bulan Januari - September Tahun 2024 adalah 96,52%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan antara lain: - Tidak terpasangnya tanda resiko jatuh di bed pasien - Tidak terpasang hand rail di bed pasien
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada bulan Januari - September tahun 2024 adalah 96,52%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Adapun tindak lanjutnya: - Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh. - Monitoring dan Evaluasi terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh. Follow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

Tabel 11. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh	Koordinasi dengan kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan, SDM	kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan, SDM	Satu Bulan
2	Monitoring dan Evaluasi terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh	Monitoring dan evaluasi berkala	Kepala Ruangan, Komite Mutu	Satu Bulan

10. Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway

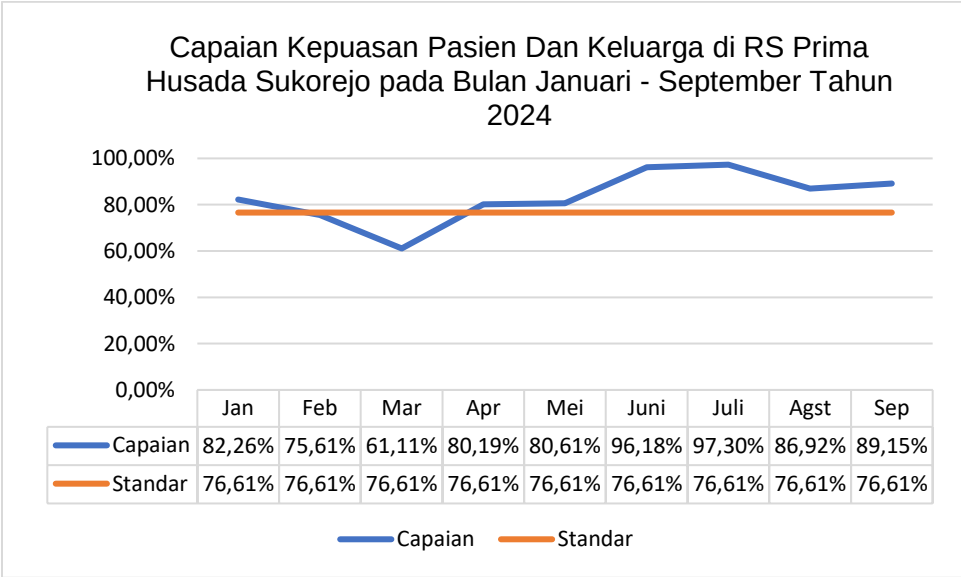


Gambar 11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari – September Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada bulan Januari September capaian kepatuhan terhadap clinical pathway di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 80,78%, sedangkan pada bulan September sendiri yaitu 89,53%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Capaian di Bulan September 2024 ini naik dari capaian di Bulan Agustus 2024 yakni 84,85%.

11. Kepuasan Pasien Dan Keluarga



Gambar 12. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari – September Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan Januari - September 2024 sudah mencapai standar yakni 83,26%. Capaian Bulan September meningkat dibanding pada Bulan Agustus yakni 2,23%.

12. Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

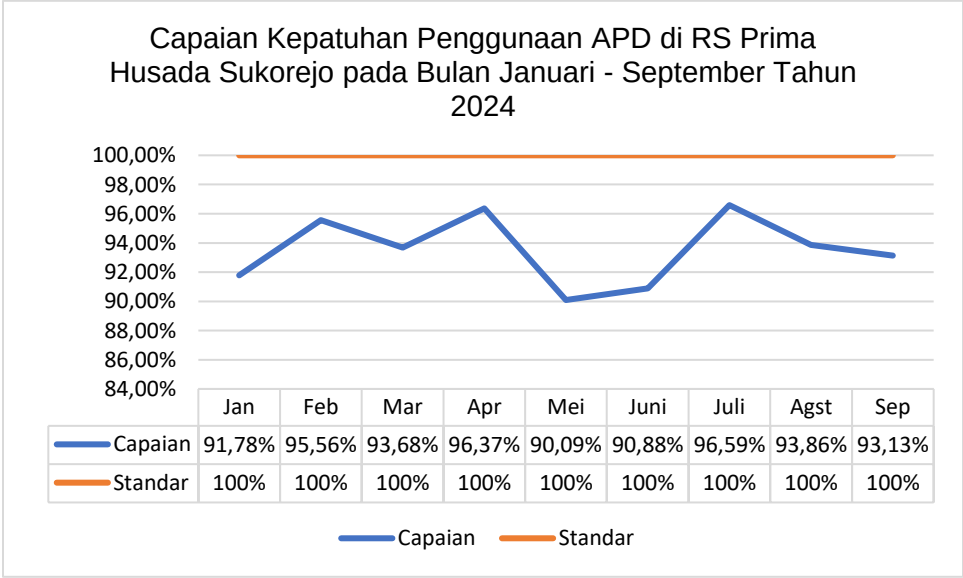


Gambar 13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari - September Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada bulan Januari sampai bulan September 2024 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)



Gambar 14. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari - September Tahun 2024

Hasil Capaian :
Pada grafik tersebut diketahui bahwa kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Januari - September 2024 adalah 93,55%.

Tabel 12. PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Bulan September Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Januari - September yaitu 93,55%, angka tersebut tidak mencapai standar 100%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD oleh petugas di RS Prima Husada Sukorejo 2. Harapan: Seluruh staf pelayanan patuh dalam penggunaan APD sehingga target kepatuhan dapat dicapai 3. Tindakan a) Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. b) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD c) Koordinasi dengan Komite PPI untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit.
Do	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan berikutnya.
Study	1. Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD Bulan Januari - September mencapai 93,55% yang belum mencapai standar 100 2. Rata-rata unit dengan capaian terendah dalam penggunaan APD yakni Unit Laboratorium yakni 57% dimana petugas ditemukan tidak menggunakan Gown di Area Sampling.
Action	1. Review dan evaluasi penggunaan APD pada staf. 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Kolaborasi dengan komite PPI untuk monitoring penggunaan APD di unit.

	4. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 5. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di unit.
--	--

Tabel 13. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf.	Staf dapat melaksanakan penggunaan dan melepaskan APD sesuai langkah dengan indikasinya	Seluruh staf rawat inap dapat melaksanakan penggunaan APD dan pelepasan APD 100% benar	Resosialisasi	Komite PPI	Satu bulan
2	Beri feedback pada hasil temuan.	Ruangan dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki	All ruangan yang di audit	Pemberian feedback	Komite PPI	Satu bulan
3	Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk review kebutuhan penggunaan APD	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat	Rapat dengan komite keperawatan	Komite PPI dan komite keperawatan	Satu bulan
4	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan APD tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan penggunaan APD tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi	Komite PPI	Satu bulan

Direktur RS Prima Husada Sukorejo,



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.